

Infermieristica nell'assistenza del paziente chirurgico

17/10/2019 -----> Bacigalupo

Nursing perioperatorio:

1. Fase preoperatoria: inizia quando un medico pianifica un intervento chirurgico e termina quando l'individuo viene portato in sala operatoria
2. Fase intraoperatoria: inizia quando un individuo viene portato in sala operatoria e termina con il trasferimento in unita' di cura post anestesia
3. Fase postoperatoria: inizia con il ricovero in PACU e termina quando il processo di guarigione ha avuto termine; tale fase puo' pertanto continuare dopo il ricovero.

Il reparto di degenza chirurgica e' un ambiente igienico atto a salvaguardare la salute del paziente chirurgico, microclima secondo le indicazioni di legge nelle camere di degenza, ambienti per personale infermieristico, cucinetta, servizi igienici per pazienti e per la vuota locali per raccolta materiali sporchi, locale per anamnesi visite al paziente medicazioni. Gli scopi della chirurgia sono: diagnostica, curativa, trapianto, estetica e palliativa. La grande chirurgia cura le principali alterazioni degli organi o delle strutture del corpo, possibilita' di grandi perdite di sangue, durante il procedimento, rischio di complicazioni durante o dopo. La piccola chirurgia si occupa di interventi non complicati, breve durata, minima perdita di sangue. Il grado di urgenza varia:

- Emergenza --> immediatamente al fine di salvare la vita del soggetto.
- Urgenza --> non appena le condizioni lo permettono (12-48 ore).
- Necessaria --> possono essere programmati necessariamente per il benessere della persona.
- Interventi opzionali --> non essenziali.

Gli interventi chirurgici si distinguono in: **puliti** (non drenati, non infetti, non traumatici, asseza processi infiammatori, non interessano l'apparato respiratorio, genitourinario e gastroenterico), **puliti-contaminati** (interventi sull'apparato respiraorio, genitourinario, gastroenterico, assenza di bile o urine infetta) **contaminati** (secondari a traumi, ferite aperte, importante contaminazione per spandimento contenuto gastrointestinale) e **sporchi** (secondari a traumi presenza di tessuto devitalizzato, contaminazione fecale, perforazione di visceri, processo infiammatorio acuto purulento). I piu' puliti vanno in sala per primi, mentre i piu' sporchi per ultimi, se invece e' un paziente siero positivo, esso andra' per ultimo anche se l'intervento e' il piu' pulito come la safenectomia. Il team chirurgico e' composto da: **infermieri** (fase pre, intra e post operatoria), **personale di supporto** (OSS,OTA, barelliere), **personale medico**. Le alterazioni psicofisiologiche secondarie all'intervento chirurgico possono variare dall'alterazione della risposta allo stress, all'alterazione della sensibilita' e ai disturbi del sonno. Le alterazioni psico-sociali possono causare disturbi dell'immagine del corpo, dell'idendita' e dell'autostima, e alterazione dello stile di vita e di natura economica.

L'incisione chirurgica e' la sezione della cute e dei tessuti sottostanti praticata dal chirurgo per raggiungere il "sito operatorio" situato in profondita' o no; essa deve favorire una buona visione del sito, rispettare l'innervazione dei muscoli, garantire una rapida e valida riparazione tissutale ed essere esteticamente accettabile. Possono essere: laparotomica, toracotomica. Il diritto della persona all'autodeterminazione e' protetto dal consenso informato e cio' di decidere se la chirurgia e' nel suo miglior interesse... Art. 32 costituzionale nessuno puo' essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge; un paziente ha diritto di rifiutare l'operazione anche dopo aver dato il consenso informale. L'obbligo di informare il paziente e' del medico che formula la proposta terapeutica e che da esecuzione alla stessa.

Fase preoperatoria: scopo dell'assistenza infermieristica in quest fase e' correggere le alterazioni funzionali in atto, latenti o potenziali, per ridurre il rischio post-operatorio. Cercare, identificare, correggere quanto potenzialmente potrebbe compromettere la guarigione della persona. Bisogna fare: un esame obiettivo, valutare il rischio chirurgico (eta', stato di salute, farmaci, mobilita', stato di nutrizione, equilibrio idro elettrolitico e condizioni psicosociali), i fattori di rischio correlati alla malattia (natura della malattia, localizzazione, durata della malattia, entita' dell'intervento chirurgico). Questa valutazione e' funzionale ad ottenere informazioni diagnostiche e prognostiche supplementari alla storia clinica, e' ritenuta necessaria quando sia prevista una prestazione anestesiológica, puo' essere omessa nei casi di paziente apparentemente sani candidati ad anestesia locale. La classificazione ASA e' del rischio anestesiológico. Le decisioni di eseguire esami di laboratorio, indagini strumentali o visite specialistiche devono essere valutati in base all'eta' del paziente, fattori di rischio, tipo di procedur chirurgica. L'obiettivo primario e' ridurre esami inappropriati eseguiti con conseguente spreco di sangue e tempo. Prima di un'operazione bisogna eseguire: emocromocitometrico (rossi, bianchi, piastrine, Hb, ematocrito, prova leucocitaria), prove di coagulazione, elettroliti del siero (Na, K, Cl), Fe, Ca, Mg, glicemia a digiuno, azotemia/creatinina, GOT, GPT, GGT, bilirubina diretta e Tot., colinesterasi, gruppo sanguigno e prove crociate, albumina e proteine Tot., analisi delle urine, sierodiagnosi per antigeni virali (HIV, HPV, HCV, HBV), marcatori tumorali se diagnosi sospetta o certa (solo se il soggetto e' entrato con diagnosi sospetto o certo K, CA 19.9 marcatori intestinali, pancreatici, CA 15.3 mammella, PSA prostatico, PAP fosfatidica acida prostatica), amilasi, lipasi (calcolosi della colecisti, sospetta pancreatite), FT3, FT4, TSH (nodulo tiroide), Beta HCG, radiografia del torace, ECG, peso corporeo, emo GAS.

04/11/2019 ----> Vassalini

I farmaci sono sostanze composte da principi attivi ed eccipienti; esso puo' essere medicamentoso a dose opportuna oppure tossico-dannoso. Essi si dividono in: **specialita' medicinali** (protetti da brevetto, esiste una casa farmaceutica che lo ha inventato), **generici** (non piu' protetti da brevetto), **galenici** (es. glucosio, fisiologica), **magistrali** (estemporanei), omeopatici (prevenire la comparsa di sintomi) - fitoterapici (a base di erbe). Il profilo professionale recepito con **il Decreto del Ministero della Salute del 14 marzo 1994 n°739**, specifica che compete all'infermiere la **"corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutico"**, (art. 1, terzo comma).

Da un punto di vista giuridico e' possibile scomporre la procedura terapeutica in: prescrizione (medico) e somministrazione (infermiere); esclusivamente in caso di emergenza (da dimostrare) l'infermiere puo' somministrare farmaci senza prescrizione e non e' punibile ai sensi dell'art. 54 del Codice di procedura Penale. Se non si dimostra l'emergenza, l'infermiere puo' andare incontro ai reati di lesioni personali o omicidio colposo. La somministrazione della terapia e' un atto **unitario, sequenziale e cronologico**; Unitario in quanto deve essere compiuto da una sola persona e la mancata conoscenza degli effetti dei farmaci, delle interazioni con altri farmaci non e' accettabile neanche da un punto di vista deontologico. L'art. 13 del Codice Deontologico degli Infermieri (2019) recita che l'infermiere assume responsabilita' in base al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Diverso e' il caso delle prescrizioni condizionate al verificarsi di un evento futuro e incerto. All'interno di esse puo' essere utile operare una distinzione tra le prescrizioni basate su: segni clinici rilevabili dall'infermiere, oppure su sintomi. Nel primo caso, la prescrizione rimane condizionata, ma e' ancorata ai segni clinici, per esempio PA, TC, etc... Che l'infermiere puo' rilevare in modo oggettivo e completare la descrizione del medico. Piu' insidiosa e pericolosa e' la **prescrizione condizionata a sintomi**, infatti esso e' riferito dal paziente e non e' quindi rilevabile oggettivamente dall'infermiere (es. dolore), in questo caso l'infermiere si assume le stesse responsabilita' del medico (Benci 2008). Una prassi molto in uso e' la prescrizione secondo protocollo, quello a cui si fa riferimento e' un protocollo terapeutico che viene affrontato sempre piu' frequentemente soprattutto per quanto riguarda la terapia infusiva, la gestione della Ta, PA, glicemia etc. Il protocollo deve essere inserito nella cartella clinica e deve essere costituito da tutti gli elementi di una prescrizione di terapia con particolare riguardo alla quantita' di farmaci e/o liquidi da somministrare, al tempo di somministrazione, alla via etc. In caso di dubbi sul dosaggio prescritto dal medico, l'infermiere ha l'obbligo di attivarsi "al preciso scopo di ottenere una precisazione per iscritto dal medico" (Cassazione Penale, IV sezione, sentenza 1668 del 25 ottobre 2000). Il rischio clinico e' dato da: **evento sentinella (danno grave non intenzionale) in cui le condizioni mi hanno portato a sbagliare e da allarme a possibili errori futuri collegati, "near miss" o quasi evento ovvero quando l'operatore che somministra la terapia si rende conto che c'e' qualcosa che non va, errore in terapia (es. 2. farmaci LASA, 1. scambio di persona, ecc.) sono gli errori piu' frequenti, errore nella trascrizione (medico), farmaci off label (al di fuori dell'uso comune), farmaci ad alto rischio (high-alert medication).**

- **Effetto collaterale: qualsiasi effetto non intenzionale di un farmaco che insorga alle dosi normalmente impiegate nell'uomo.**
- **Evento avverso: qualsiasi fenomeno clinico spiacevole che si presenta durante un trattamento con un farmaco, ma che non abbia necessariamente un rapporto di casualita' o di relazione con il trattamento stesso.**
- **Reazione avversa: risposta ad un farmaco che sia nociva e non intenzionale e che avvenga alle dosi normalmente usate per la profilassi, la diagnosi o la terapia della malattia. Nella definizione vengono comprese tutte le dosi di farmaco prescrivibili clinicamente, ma viene esclusa l'overdose accidentale o deliberata (cambia la gravita' rispetto all'effetto collaterale).**
- **Reazione avversa inattesa: la cui natura e severita' non e' riportata nel foglietto illustrativo o nella autorizzazione alla commercializzazione del farmaco o che sia inattesa rispetto alle caratteristiche del farmaco stesso.**

- **Reazione avversa o evento avverso serio: qualsiasi evento spiacevole che, per qualsiasi dose metta in pericolo la vita del paziente, richieda l'ospelizzazione del paziente o prolunghi una ospedalizzazione gia' avvenuta, o determini una persistente o significativa disabilita' o incapacita' (es. Provochi la morte, comporti un'anomalia congenita o un difetto alla nascita).**

18/11/2019 -----> Bacigalupo

I liquidi chiari comprendono l'acqua i succhi senza polpa, le bevande gassate, caffe' (alcol escluso). Il paziente viene messo in uno stato di digiuno prima dell'intervento per prevenire vomito e aspirazione. Nelle linee guida si raccomanda di non bere liquidi due ore prima dell'operazione; in alcuni pazienti e' indicato il posizionamento del sondino per decomprimere lo stomaco e permettere la rimozione del suo contenuto.

21/11/2019 -----> Vassalini

La gestione dei farmaci e' un processo continuo e circolare che si caratterizza per una sequenza di fasi:

1. **Conservazione** --> comprende la documentazione (sotto forma di procedure), il luogo (locali, armadi, frigoriferi...), le condizioni di conservazione (ossigeno, luce, temperatura, umidita'). Quelli che devono essere conservati in modo particolare: stupefacenti, campioni, pericolosi, scaduti o imperfetti, difettosi o contenenti corpi estranei.
2. **Preparazione** --> il contesto ambientale, l'integrita' e le caratteristiche della formulazione, la modalita' e i tempi di ricostituzione, la stabilita' chimico-fisica, l'allestimento della soluzione.
3. **Somministrazione** --> la regola delle 6/8/G (giusto farmaco, dose, orario, via, persona, registrazione + approccio alla persona e monitoraggio).
4. **Monitoraggio** -->

04/12/2019 --> Vassalini

Le vie si dividono in:

- **Enterali**

Via sublinguale --> assorbimento rapido a livello del dorso della lingua e del pavimento della bocca.

Via orale --> facile e veloce ma l'assorbimento e' variabile perche' condizionato dai tempi di permanenza del farmaco nello stomaco e dai tempi di svuotamento gastrico.

Via rettale --> l'assorbimento del principio attivo puo' risultare irregolare e incompleto, e' praticabile solo per alcune indicazioni.

- **Parenterali**

- **Vie non iniettive:**

Via respiratoria --> assorbimento buono e tempi rapidi, la superficie di assorbimento e' composta dal letto vasale polmonare e' ampia e ideale per farmaci allo stato gassoso o preparato per aerosol.

Via nasale --> indicata per pz aggressivi e bambini, assorbimento immediato in quanto i farmaci accedono direttamente al SNC senza passare per il fegato, indicato per i farmaci contro il dolore, sedativi, ansiolitici, per combattere overdose, non si usano farmaci oleosi o vasocostrittori, i farmaci non vanno diluiti, la dose massima e' 1 cc e si usa una siringa Luer Lock con il device.

Via cutanea --> si usano farmaci ad uso topico, e farmaci con effetti sistemici grazie al controllo dell'assorbimento attraverso gli strati cutanei, con l'impiego dei sistemi transdermici.

- Vie iniettive

Via intramuscolare --> l'assorbimento e' considerato buono, mediamente rapido, e' una via adatta per la somministrazione di preparati idrosolubili, oleosi e/o irritanti. Sedi: muscolo deltoide, gluteo, vastolaterale, rettofemorale. Le *tecniche* di iniezione sono: "standard", "tratto z", e "bolla d'aria" (sconsigliata dalle evidenze scientifiche soprattutto con i nuovi dispositivi). *Procedura*: 1. Aspirare il liquido (max 5 ml) 2. Se necessario cambiare ago 3. Detergere (ridurre la carica batterica) 4. Usare la giusta velocita' di somministrazione (1 ml ogni 10 secondi) 5. Non massaggiare dopo la somministrazione. *Complicanze*: lesione nervo sciatico, ematomi, noduli persistenti, infezioni, ascessi, necrosi tissutali, lesioni ossee.

Via endovenosa --> i tempi di assorbimento attraverso questa via sono rapidi, gli effetti sono immediati, il dosaggio puo' essere stabilito in modo molto preciso. Questa via non e' adatta alla somministrazione di preparati non solubili e soluzioni oleose. Si puo' somministrare in bolo, in infusione continua o in infusione intermittente. Per prevenire le complicanze bisogna diluire, garantire la sterilita', la pervieta' della vena e assicurarsi che la velocita' di infusione sia corretta. *Complicanze*: infezioni, flebiti, stravasamento, ostruzione, embolia gassosa, shock di infusione rapida (Plasil se iniettato troppo velocemente puo' causare tachicardia, di conseguenza bisogna che venga diluita in almeno 10 cc molto lentamente senno' meglio in una flebo da 100 cc).

I cateteri venosi sono: butterfly, ago canula

I cateteri venosi centrali sono: non tunnellizzati (provvisori) di cui a inserzione periferica (PICC) o Midline, sistemi totalmente impiantabili (port-a-cath) ago di Huber.

Via sottocutanea --> assorbimento buono, tempi lenti ad eccezione dell'eparina. Non va effettuata nelle zone che presentano segni di infiammazione, ematomi, esiti di cicatrici, edema; nelle terapie a lungo termine e' importante l'impiego delle "mappe di rotazione". Sedi: muscolo deltoide, zona sopra e sotto scapolare, zona addominale, zona dorsogluteale e zona vastolaterale.

Via intradermica --> assorbimento variabile, tempi lenti, indicata per azioni locali. Sedi: superficie volare dorsale dell'avambraccio, dorsale del braccio, zona antero/superiore del torace, zona scapolare.

05/12/2019 --> Vassalini

Via epidurale --> assorbimento lento, gli effetti sono sia sistemici che locali, prima della somministrazione va sempre controllata la limpidezza della soluzione, in assenza di essa la stessa non va impiegata (elastomero).

Via intraossea --> pazienti critici (epilettici, tossicodipendenti, in arresto cardiaco, in distress respiratorio, con trauma maggiore), e' un atto medico delegato, si utilizza uno spazio osseo vascolarizzato. *Vantaggi:* pari ad un accesso venoso, assorbiti velocemente, tutti i farmaci possono essere usati ad uso endovenoso, si possono fare prelievi ematici, si possono fare trasfusioni, l'osso non collassa (al contrario dei vasi). *Svantaggi:* si puo' lasciare in situ per 12-24 ore al massimo, e' molto doloroso, c'e' rischio di osteomielite da stravasamento. *Indicazioni cliniche:* GCS < 12, PA (massima) < 90, FR <10 o > 29, grandi ustioni, traumi midollari. *Controindicazioni:* frattura ossea, osteoporosi severa, infezione in sede. *Siti:* adulto (testa dell'omero, tibia prossimale e distale, femore distale, sterno), bambini (tibia prossimale e distale, femore distale e omero prossimale). La somministrazione del farmaco deve essere sempre seguita da un bolo di soluzione fisiologica.

Somministrazione attraverso SNG --> verificare se il farmaco si puo' diluire, preparare il farmaco, sciacquare il sondino, chiudere il sondino subito dopo.

Giusto approccio alla persona: il paziente ha diritto ad essere informato e quindi e' necessario fornire alla persona informazioni dettagliate e comprensibili, il paziente deve rilasciare il consenso per l'iter terapeutico (consenso informato/implicito). Bisogna monitorare la persona con gli effetti attesi, collaterali, gli eventi avversi, le reazioni avverse, e gli stili di vita del paziente.

Farmaci

Apparato gastroenterico: alginati (quando pH alterato), antisecretivi (cellule stimulate prima di agire, mezz'ora prima di mangiare), stimolanti la motilita'

Apparato cardiovascolare: diuretici, diuretici risparmiatori di potassio, diuretici con potassio, diuretici dell'ansa, ace-inibitori, antagonisti di recettori dell'angiotensina II, calcio antagonisti, betabloccanti, nitrati, eparina, digossina, acidoacetilsalicilico, warfarin, amiodarone.

Altri farmaci: ormoni, antibiotici, antiepilettici, sedativi, antidepressivi, contro l'insonnia.

Diabete: ipoglicemizzanti orali (sulfoniluree non obesi, biguanidi per obesi), insulina (effetto rapido, intermedia o lunga e bifasiche)

FARMACI ESAME DI TIROCINIO ED ESAME PZ. CHIRURGICO.

LANOXIN

Principio attivo: digossina

Scopo: aumenta la forza contrattile del cuore

Forme terapeutiche: capsule, compresse, gocce, sciroppo, soluzione.

Tempo e somministrazione: le fiale possono essere addizionate ad una fisiologica, a glucosata al 5% e al 4% di glucosio + 0,18% di sodio cloruro, solamente per via endovenosa, se somministrato in bolo il tempo di infusione non deve essere inferiore a 15 minuti, anche l'infusione deve essere lenta.

Effetti indesiderati: anoressia, cefalea, confusione mentale, diarrea, disturbi del ritmo e della conduzione, disturbi visivi (scotomi, disorientamento), tosse, bradicardia, nausea, vomito.

Interventi: bisogna misurare il polso, fare prelievo di digossinemia.

LASIX

Principio attivo: furosemide

Scopo: inibiscono il riassorbimento del sodio del tratto ascendente dell'ansa di Henle nel tubulo renale.

Forme terapeutiche: compresse, soluzioni.

Per la somministrazione in infusione il preparato può essere diluito in soluzioni alcaline neutre con scarsa capacità tampone, soluzione fisiologica o ringer; non deve essere diluito in soluzioni acide con capacità tampone elevate, e non può essere miscelato nella stessa siringa con altri farmaci.

Dose: compresse da 25 mg, raramente in 500 mg.

Tempo somministrazione: in bolo 1-2 minuti, in infusione velocità non superiore a 4 mg al minuto.

Modalità di somministrazione: al mattino ed è necessario arricchire la dieta con alimenti con potassio (patate, banane, arance, pomodori, spinaci, frutta secca).

Effetti indesiderati: disturbi gastroenterici, stanchezza, vertigini, aumentata traspirazione, disturbi della minzione, se usato in eccesso causa severa disidratazione, ipotensione, aritmie cardiache e squilibri elettrolitici, debolezza muscolare.

COUMADIN

Principio attivo: warfarin

Scopo: mantenere il sangue più fluido, per la terapia dell'embolia polmonare e la trombosi venosa profonda, prevenzione in pazienti sottoposti a sostituzione valvolare con valvole meccaniche.

Forme terapeutiche: compresse.

Modalità di somministrazione: 2 ore prima del pasto e 2 ore dopo il pasto.

Interazione con farmaci: no alcool e antiinfiammatori con steroidi, no alimenti ricchi di vitamina K (ceci, carne di maiale, fegato, vegetali a foglia verde larga, cavolini di Bruxelles, cavoli, broccoli, spinaci e lattuga).

Effetti indesiderati: emorragie, dolore, gonfiore, sangue dal naso, urine brune, feci rosse, mal di testa, vertigini e debolezza.

